

TEMA 4.5 • DERMATOLOGÍA

Acné

PERFIL EUNACOM 6.01.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Acné

El Acné resulta dentro de todo el abanico en la enfermedad cutánea estético-infecciosa de primer orden poblacional, impactando severamente el desarrollo biológico y psicológico base de la pubertad y juventud mediante sus brotes de inflamación folicular de la glándula sebácea folicular facial de recambio y la colonización subyacente de su bioma local.

Etiopatogenia Multifactorial Integrada

(Intervienen 3 ejes de cascadas interconectadas en el inicio de la espiral y NO dependen del consumo de dieta ni chocolates/cacaomas en sí puramente): 1. **Factor Endógeno Hormonal:** Repunte y superpoblación de **hormonas esteroidales Andrógenas** (De ahí la excelente efectividad remediadora de los clásicos anticonceptivos Anti-androgénicos en la línea de las mujeres). 2. **Defecto Estructural Genético:** Alteración perjudicial por una extrema hiperqueratinización aberrante folicular que obtura mecánicamente el poro natural glandular, atestándolo bajo compresión al exterior. 3. **El Invasor Microbiológico:** Colonización y reproducción endémica bacteriana extrema en el sebo desoxigenado ocluido producida por el bacilo endógeno **Cutibacterium acnes / Propionibacterium acnes**.

Fenotipos y Escalada Morfológica Infecciosa de Lesiones

Las áreas mayormente colapsadas y atestadas predilectas involucran el territorio graso universal predispuesto (**Todo el segmento de la Cara, pecho central pre-esternal y la zona vasta de la Espalda**).

- **Fase de Acné Comedoniano Puro Leve:** Es el estadio basal aséptico puro y es el que presenta la incólume presencia de la sagrada y requerida **Lesión Elemental Patognomónica: "El Comedón"**.
- **- Comedón Abierto:** Tapón negro externo asfixiado expuesto (oxidación lipídica del estroma central).
- **- Comedón Cerrado:** Tapadera microscópica sin orificio ciego; una microscópica papulita abultada tensa por debajo.
- **Fase del Acné Inflamatorio Eruptivo:** Evolución supurativa infecciosa por inflamación local que muta el comedón integrándole un anillo rojo de envergadura, generando micro lagunas pustulosas (**Pápulas y Pústulas difusas rojas abundantes purulentas**) y escalando finalmente de no mediar intervención a tumoraciones císticas basales de gran envergadura tridimensional internas de pus, (**Acné Nódulotico y Acné Quístico severo**) percutiendo el plano deformando con cicatrices masivas faciales deprimidas.

Variedades Oncológicas/Toxigénicas Inestables Extremas del Acné (Emergencia Terapéutica)

- **Acné Conglobata:** Un monstruo necrótico masivo del acné, un conglomerado gigantesco en la espalda que engloba un enjambre entrelazado y supurativo de nódulo-quistes inflamatorios crónicos que barren e instalan cicatrices atróficas y lagunas interconectadas con fistulas sinuosas purulentas aberrantes masivas bajo la piel que minan permanentemente y sin tregua deformando dolorosamente.
- **Acné Fulminans (Forma letal grave fulminante sistémica):** Exactamente idéntico estadio purulento gigante destructivo que el percutido en el Conglobata, pero **Gatilla y Cursa letalmente un Síndrome Sistémico Severo adjunto asociado a tormentas citoquinicas acompañante de FIEBRE ALTÍSIMA** más malestar global de decaimiento postrante del paciente crónico e inclusive dolores articulares sépticos poli-reumáticos inflamatorios.

Abordaje y Escalón Terapéutico EUNACOM

- **Grado Inicial - Acné Comedoniano Leve:** Basta para depurar su evolución tópica la exfoliación química regular constante con

Retinoides Tópicos Queratolíticos (Adapaleno Tópico, Tretinoína local en crema).

- **Grado Intermedio - Acné Inflamatorio Agudo Leve (Pápulo-Pustuloso):** Exige barrido e interferencia de la colonización bacteriana subyacente para apaciguar el cráter enrojecido: **Antimicrobianos Tópicos focalizados (Elección oro: Clindamicina en Loción Tópica / Pomo)** o bien Peróxido de Benzoilo para depuración focal y desecar pústulas.
- **Grado Severo Fuerte - Acné Nódulo-Quístico Intratable masivo e hiper Inflamatorio Agudo Extenso:** La terapia de base no resiste el embate externo; obliga terapia endovenosa y recetar un choque fuerte central sistémico derivando y subiendo el escalón radical final al **Antibiótico Sistémico General Vía Oral a largo plazo crónico (De elección oro: La familia de las Tetraciclinas como la Doxiciclina o Minociclina Oral)**.

Escalón Supremo del Rescate Terapéutico Terminal: Isotretinoína Oral Definitiva

Medicamento sintético citostático y supresor supremo que no titubea para reventar y encoger las glándulas suprimiendo la matriz. Indicado transversalmente en inflamación nodular severa rebelde u escalones más bajos refractarios y crónicos a todo tratamiento tópico con antibióticos. Duración mínima prolongada perenne desde 3 a 12 meses absolutos de dosis total acumulada. **Terribles REACCIONES ADVERSAS (RAMS) Tóxicas que Obligan Preuccaciones Restrictivas Severas:** 1. Provoca universalmente y reseca "hasta el alma", evaporando las mucosas (Labios inmensamente partidos sangrantes disecados queratolíticos masivos, Ojos arenosos, prurito reseca crónico grave de la tez). 2. Es fuertemente Fototóxica: Obligando sin piedad ni misericordia la exención y prohibición radiante absoluta, esquivando baños solares estivales y uso extremo mandado de bloqueadores potentes. 3. Impacto de Daño Hepatotóxico sistémico: Alterando función perjudicial enzimática y lipídica de las grasas. 4. Y EL RIESGO SUPREMO EUNACOM: **ES FERROZMENTE TERATOGENICA MORTAL**. Resultando abortiva o inductora de monstruos embriológicos incurables fatales cerebrales, cardiovasculares. Toda mujer fértil dispuesta a esta receta debe **estar obligadamente bajo Anticoncepción Dual simultánea estricta y sin embarazo basal comprobado**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Manejo Específico Intrahospitalario EUNACOM de los casos Letales (Acné Conglobata y Acné Fulminans crónicos febriles): Son los únicos escaños en donde se requiere frenar la tormenta descontrolada inmunológica aguda que carcome al cuerpo con un freno superior endovenoso a las tetraciclinas. Se deben usar sin demora en paralelo inmediato **Corticoides Sistémicos Sistémicos Vía Oral fuertes Inmunosupresores (Ej: Corticoide Prednisona)** en conjunto armónico de base y amparado por los inmensos choques paralelos a fuego directo de la **Isotretinoína Oral sistémica prolongada en alta dosis**. Adicionado de mediar la clínica febril/fulminans la cobertura a los antibióticos empíricos potentes.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"¿Cuál es el efecto adverso más grave que debe conocerse de la isotretinoína oral?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Acné. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El comedón abierto o cerrado es la lesión elemental del acné y origen de las lesiones inflamatorias.
- La etiopatogenia del acné involucra andrógenos, Cutibacterium acnes y factores genéticos.
- Los retinoides tópicos como adapaleno o tretinoína son el tratamiento del acné comedoniano.
- La isotretinoína oral se usa en acné severo y tiene efectos adversos importantes incluyendo teratogenicidad.
- El acné conglobata y fulminans requieren isotretinoína más prednisona para su manejo.
- El tratamiento del acné debe mantenerse mínimo entre tres y seis meses para ser efectivo.
- La clindamicina tópica o peróxido de benzoilo son de primera línea en acné inflamatorio leve.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ACNÉ)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es el efecto adverso más grave que debe conocerse de la isotretinoína oral?

- A)** La hepatitis tóxica que puede evolucionar a insuficiencia hepática aguda
- B)** La teratogenicidad con graves malformaciones fetales si se usa en el embarazo
- C)** La sequedad severa de piel y mucosas que impide la vida normal del paciente
- D)** La fototoxicidad que genera quemaduras con exposición solar mínima
- E)** La depresión severa que puede llevar a conductas autolesivas

PREGUNTA 2

¿Cuál es la lesión elemental del acné a partir de la cual se desarrollan las lesiones inflamatorias?

- A)** La pústula con contenido purulento superficial
- B)** El nódulo profundo doloroso a la palpación
- C)** El comedón abierto o cerrado obstruyendo el folículo
- D)** La mácula eritematosa postinflamatoria residual
- E)** La vesícula con contenido seroso transparente

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de elección para el acné comedoniano sin componente inflamatorio?

- A)** Antibióticos tópicos como clindamicina o eritromicina al uno por ciento
- B)** Retinoides tópicos como adapaleno o tretinoína aplicados una vez al día
- C)** Isotretinoína oral en dosis de cero coma cinco miligramos por kilo diario
- D)** Peróxido de benzoilo al dos coma cinco por ciento como única medida
- E)** Corticoides tópicos de mediana potencia dos veces al día por tres semanas

RESUMEN: ACNÉ

El acné es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo pilosebáceo que afecta principalmente cara, pecho y espalda. Su lesión elemental es el comedón, que puede ser abierto o cerrado, y a partir del cual se desarrollan las lesiones inflamatorias como pápulas, pústulas y nódulos. La etiopatogenia es multifactorial con participación de andrógenos que estimulan la glándula sebácea, la bacteria Propionibacterium acnes o Cutibacterium acnes que coloniza el folículo, y factores genéticos. El tratamiento se escala según la gravedad. Para las lesiones comedonales se usan retinoides tópicos como el adapaleno o la tretinoína. Para el acné inflamatorio leve se agrega clindamicina tópica o peróxido de benzoilo. Los casos severos requieren isotretinoína oral junto con tetraciclinas. El acné conglobata y fulminans requieren isotretinoína más prednisona. La isotretinoína tiene efectos adversos importantes: sequedad de piel y mucosas, fototoxicidad, hepatotoxicidad y especialmente teratogenicidad, siendo necesaria anticoncepción en mujeres en edad fértil. El tratamiento mínimo dura tres a seis meses.